

Manual de utilização

Sistema de Registros ABA

Referência operacional e conceitual para compreender o que preencher, quando preencher e por que cada etapa importa.

Como usar este manual

Consulte o índice, localize o tema e leia os blocos de definição, finalidade, momento de uso, preenchimento e relevância. O PDF permite busca textual pelo visualizador.

Limite do material

Este guia orienta o uso do software. Não substitui formação, supervisão, avaliação individualizada, consentimento, requisitos profissionais ou julgamento clínico.

Índice

1. Das sessões iniciais ao planejamento
2. Pacientes, cadastro único e vínculos
3. Plano clínico
4. Objetivos clínicos
5. Alvos clínicos
6. Definição operacional
7. Configuração de medição
8. Critério de domínio
9. Ciclo de vida e fases
10. Mudança de fase
11. Intervenção e protocolos de ensino
12. Apoio comportamental
13. Sessões clínicas e integridade
14. Análise, domínio e revisão clínica
15. Participação, validade social e capacitação
16. Equipe, privacidade e compartilhamento
17. Tentativas, ajuda e leitura contextual
18. Prontidão, revisão e aplicação da decisão

Hierarquia do planejamento

Paciente e vínculo → Sessões iniciais → Síntese da avaliação → Plano → Objetivos → Alvos → Definição e medição → Critério → Protocolo → Sessões → Análise → Revisão.

O planejamento parte de uma finalidade ampla e chega a medidas concretas. Os dados retornam para análise; a análise sustenta revisões, mudanças de fase e novas versões dos procedimentos.

1. Das sessões iniciais ao planejamento

O que é

O acompanhamento pode começar com vínculo, entrevista, avaliação ou observação sem alvos. A área Avaliação consolida essas evidências antes do planejamento.

Para que serve

Registrar o trabalho clínico anterior ao planejamento, documentar potencialidades, necessidades e prioridades e manter requisitos progressivos para cada finalidade.

Quando preencher ou revisar

Logo após vincular o paciente e sempre que um novo alvo for incluído.

Como preencher e utilizar

- Use vínculo, entrevista, avaliação, observação ou orientação antes do planejamento.
- Em Avaliação, vincule as sessões consideradas e registre fontes, potencialidades, necessidades e prioridades.
- Salve rascunhos e conclua uma versão quando houver base suficiente.
- Use a síntese concluída para justificar plano e objetivos.
- Para linha de base, o protocolo não é obrigatório.
- Configure critério e protocolo antes da intervenção e registre a integridade.

Por que é relevante

Conecta cada medida à sua finalidade, fase e intervenção, permitindo análise e revisão confiáveis.

Atenção

Sessões iniciais não entram nos gráficos de alvos. Linha de base exige alvo e medição; intervenção também exige protocolo.

2. Pacientes, cadastro único e vínculos

O que é

O paciente é um cadastro único. O vínculo define quais profissionais estão autorizados a trabalhar com ele; possuir login não concede acesso.

Para que serve

Evitar duplicidade, preservar um histórico coerente e separar autenticação de autorização.

Quando preencher ou revisar

Antes do primeiro planejamento. Se houver correspondência, solicite acesso; se for novo, conclua o cadastro.

Como preencher e utilizar

- Informe dados suficientes para a verificação.
- Confirme correspondências somente pelos dados mínimos mascarados.
- Acompanhe pedidos em Solicitações.
- Revise vínculos quando a composição da equipe mudar.

Por que é relevante

Cadastros duplicados fragmentam histórico, decisões e compartilhamentos.

Atenção

A busca de duplicidade não deve ser usada como consulta livre de pessoas.

3. Plano clínico

O que é

Estrutura que reúne objetivos e alvos relacionados a uma necessidade clínica. Seu status pode evoluir de rascunho até encerrado.

Para que serve

Registrar a direção geral do trabalho, sua justificativa e o período de revisão.

Quando preencher ou revisar

Depois de compreender a demanda e antes de cadastrar alvos isolados.

Como preencher e utilizar

- Use um título que identifique o foco.
- Descreva a justificativa clínica.
- Defina início e revisão.
- Atualize o status conforme o plano avança.

Por que é relevante

Impede que alvos se tornem tarefas desconectadas de uma finalidade relevante.

Atenção

Não crie um plano novo apenas para organizar a tela; use outra estrutura quando houver finalidade clínica distinta.

4. Objetivos clínicos

O que é

Resultados funcionais amplos, de curto ou longo prazo, que agrupam alvos relacionados.

Para que serve

Conectar medidas específicas a mudanças significativas para a pessoa.

Quando preencher ou revisar

Depois do plano e antes dos alvos. Revise quando a prioridade funcional mudar.

Como preencher e utilizar

- Escreva em linguagem funcional.
- Indique o horizonte de tempo.
- Evite descrever procedimentos como se fossem resultados.
- Ordene por prioridade.

Por que é relevante

A equipe consegue compreender a direção do trabalho sem depender dos detalhes de cada medida.

5. Alvos clínicos

O que é

Unidades observáveis e mensuráveis do acompanhamento. Podem ser de aquisição ou de redução.

Para que serve

Transformar um objetivo amplo em algo que possa ser medido e revisado.

Quando preencher ou revisar

Quando houver razão clínica clara, definição possível e condições reais de coleta.

Como preencher e utilizar

- Dê um nome reconhecível.
- Associe ao objetivo correto.
- Escolha natureza e fase.
- Complete definição, medição, critério e protocolo.

Por que é relevante

Sessões, gráficos, critérios e revisões se conectam ao alvo.

Atenção

Evite rótulos vagos ou estados internos não observáveis.

6. Definição operacional

O que é

Descrição objetiva do que conta e do que não conta como resposta, com condições, exemplos e não exemplos.

Para que serve

Permitir que pessoas diferentes reconheçam a mesma ocorrência.

Quando preencher ou revisar

Antes da primeira medição e sempre que a definição deixar de representar o alvo.

Como preencher e utilizar

- Descreva ações observáveis.
- Inclua início, fim e limites relevantes.
- Registre exemplos e não exemplos semelhantes.
- Crie nova versão quando mudar.

Por que é relevante

Sustenta confiabilidade, treinamento e interpretação dos dados.

Atenção

Nunca reescreva o significado histórico de dados já coletados; versione a mudança.

7. Configuração de medição

O que é

Regra que define tipo e unidade da medida: frequência, taxa, duração, latência, oportunidades, tentativas, intervalos, amostragem, independência ou intensidade.

Para que serve

Adequar a coleta à dimensão do comportamento e permitir comparação.

Quando preencher ou revisar

Antes da coleta; revise quando a medida deixar de responder à pergunta clínica.

Como preencher e utilizar

- Escolha a dimensão relevante.
- Informe unidade e parâmetros.
- Mantenha condições comparáveis.
- Crie nova versão se a regra mudar.

Por que é relevante

Gráficos só são úteis quando os pontos representam medidas comparáveis.

Atenção

Não troque a medida apenas para melhorar a aparência do resultado.

8. Critério de domínio

O que é

Regra quantitativa e contextual com direção, valor-alvo, sessões consecutivas, oportunidades, ambientes e aplicadores.

Para que serve

Explicitar antecipadamente o que será considerado desempenho consistente.

Quando preencher ou revisar

Antes de analisar domínio; versione quando a exigência mudar.

Como preencher e utilizar

- Defina aumentar ou reduzir.
- Escolha valor coerente com a medida.
- Defina sessões consecutivas.
- Inclua ambientes e aplicadores quando houver generalização.
- Defina manutenção quando necessário.

Por que é relevante

Reduz decisões improvisadas e torna a regra auditável.

Atenção

Atingir o critério não muda a fase automaticamente nem equivale sozinho a encerramento.

9. Ciclo de vida e fases

O que é

As fases comunicam a função atual do alvo: rascunho, linha de base, ensino, generalização, manutenção, pausado e encerrado.

Para que serve

Contextualizar dados e deixar claro o que se pretende fazer com o alvo.

Quando preencher ou revisar

Na criação e sempre que evidências e decisão clínica justificarem uma transição.

Como preencher e utilizar

- Rascunho: estrutura incompleta.
- Linha de base: observar antes ou sem a intervenção planejada.
- Ensino: aplicar o protocolo.
- Generalização: verificar novas pessoas, ambientes, estímulos ou respostas.
- Manutenção: verificar estabilidade no tempo.
- Pausado: interromper temporariamente.
- Encerrado: finalizar trabalho ativo preservando o histórico.

Por que é relevante

A mesma medida tem significados diferentes em linha de base, ensino ou manutenção.

Atenção

Não avance apenas porque o último ponto melhorou.

10. Mudança de fase

O que é

Transição registrada entre fases, acompanhada de justificativa.

Para que serve

Relacionar mudanças no acompanhamento às evidências e decisões que as motivaram.

Quando preencher ou revisar

Após revisar dados, integridade, contexto, prioridade e condições do paciente.

Como preencher e utilizar

- Revise o período relevante.
- Confira integridade e desvios.
- Considere contextos e validade social.
- Escolha a fase e justifique.
- Confirme se protocolo, medida e critério continuam adequados.

Por que é relevante

Cria rastreabilidade e ajuda a interpretar mudanças posteriores na tendência.

Atenção

Melhora isolada, ausência de dados ou conveniência operacional não bastam como justificativa.

11. Intervenção e protocolos de ensino

O que é

Descrição versionada da estratégia, hierarquia de ajuda, esvanecimento, reforçadores, esquema, correção de erro e instruções.

Para que serve

Transformar a intenção clínica em procedimento aplicável, treinável e revisável.

Quando preencher ou revisar

Antes das sessões de ensino e sempre que uma mudança material alterar a aplicação.

Como preencher e utilizar

- Escolha estratégia compatível.
- Descreva a hierarquia de ajuda.
- Planeje esvanecimento.
- Defina reforçadores e esquema.
- Explique a correção de erro.
- Inclua instruções suficientes.

Por que é relevante

Permite relacionar resultados ao procedimento vigente em cada sessão.

Atenção

Documentação no sistema não valida competência, ética ou segurança do procedimento.

12. Apoio comportamental

O que é

Plano para alvos de redução que reúne hipótese funcional, antecedentes, comportamento substitutivo, ensino, consequências, segurança e revisão.

Para que serve

Organizar prevenção e ensino de alternativas, mantendo coerência entre pessoas e ambientes.

Quando preencher ou revisar

Após reunir informações suficientes para uma hipótese prudente; revise diante de novos dados ou baixa efetividade.

Como preencher e utilizar

- Declare a função como hipótese.
- Registre evidências.
- Planeje estratégias antecedentes.
- Defina e ensine o substitutivo.
- Registre consequências e segurança.
- Defina critérios de revisão.

Por que é relevante

Evita tratar redução sem compreender contexto ou ensinar alternativas relevantes.

Atenção

Registros ABC são descritivos e não confirmam função por si só.

13. Sessões clínicas e integridade

O que é

Registro contextualizado de data, ambiente, aplicador, alvos, medidas e integridade. Medidas por oportunidades podem detalhar resultado, nível de ajuda e latência de cada tentativa.

Para que serve

Relacionar resultados às condições reais de aplicação.

Quando preencher ou revisar

Em cada encontro com coleta válida, durante ou logo após a observação.

Como preencher e utilizar

- Escolha o paciente correto.
- Informe ambiente, aplicador e contexto.
- Inclua apenas alvos trabalhados.
- Em tentativas discretas ou oportunidades, detalhe resultado, ajuda e latência quando necessário.
- O resumo é calculado a partir das tentativas detalhadas.
- Marque componentes aplicados e explique desvios.

Por que é relevante

Sessões completas aumentam a confiabilidade de gráficos, domínio e revisões.

Atenção

Somente o autor pode cancelar ou restaurar. O cancelamento retira a sessão dos gráficos e tokens, mas preserva histórico e auditoria.

14. Análise, domínio e revisão clínica

O que é

Séries históricas na unidade original de cada alvo, com critérios, fases, protocolos, integridade, contexto e revisões.

Para que serve

Apoiar decisões sobre manter, modificar, avançar, retornar, pausar ou encerrar.

Quando preencher ou revisar

Em revisões programadas, ausência de progresso, mudança relevante, possível domínio ou variabilidade incomum.

Como preencher e utilizar

- Filtre alvo, período, fase, ambiente e aplicador.
- Leia ocorrências, taxa, segundos, percentual ou nível sem misturar unidades.
- Observe nível, tendência e variabilidade.
- Use o critério como referência, não como decisão automática.
- Confira fase, protocolo e integridade.
- Registre decisão e justificativa.

Por que é relevante

A decisão documentada preserva continuidade e responsabilidade clínica.

Atenção

Indicadores apoiam, mas não substituem análise profissional nem demonstram causalidade sozinhos.

15. Participação, validade social e capacitação

O que é

Validade social registra relevância, aceitabilidade, viabilidade, benefício e assentimento. Capacitação documenta instrução, modelação, ensaio, feedback e competência.

Para que serve

Verificar se objetivos e procedimentos fazem sentido e se aplicadores conseguem implementá-los.

Quando preencher ou revisar

No planejamento, em revisões, após mudanças e quando participação ou viabilidade puderem alterar decisões.

Como preencher e utilizar

- Identifique o respondente.
- Registre relato concreto e assentimento observado.
- Documente adaptações.
- Marque componentes realmente treinados.
- Separe competência de presença.
- Planeje acompanhamento.

Por que é relevante

Resultados técnicos podem não ser relevantes, aceitáveis ou sustentáveis.

Atenção

Assentimento observado não substitui consentimento formal.

16. Equipe, privacidade e compartilhamento

O que é

Conjunto de profissionais explicitamente vinculados, com autoria e limites de acesso. Compartilhamentos externos possuem escopo e validade.

Para que serve

Permitir colaboração sem acesso irrestrito ao prontuário.

Quando preencher ou revisar

Ao entrar ou sair alguém da equipe e sempre que houver finalidade legítima para acesso externo.

Como preencher e utilizar

- Confirme vínculos na área Equipe.
- Escolha o menor escopo e período necessários.
- Selecione alvos e se critérios, fases, integridade e contextos serão exibidos.
- Mantenha apenas tokens necessários.
- Revogue acessos sem finalidade ativa.
- Observações privadas e registros ABC não entram no portal.

Por que é relevante

Autorização mínima reduz exposição e preserva responsabilidade por cada registro.

Atenção

Administração técnica não equivale a autorização clínica irrestrita.

17. Tentativas, ajuda e leitura contextual

O que é

A coleta detalhada separa respostas corretas independentes, corretas com ajuda, incorretas e sem resposta, além de níveis de ajuda e latência.

Para que serve

Verificar dependência de prompts, esvanecimento e consistência contextual.

Quando preencher ou revisar

Em tentativas discretas ou oportunidades, quando houver critérios consistentes de observação.

Como preencher e utilizar

- Registre apenas tentativas observadas.
- Diferencie correta independente de correta com ajuda.
- Escolha o nível de ajuda utilizado.
- Informe latência com início e término definidos.
- Compare blocos recentes e cobertura.

Por que é relevante

O agregado pode melhorar enquanto a dependência de ajuda continua alta.

Atenção

Poucas sessões, protocolos diferentes ou baixa integridade limitam a interpretação.

18. Prontidão, revisão e aplicação da decisão

O que é

Fluxo auditável entre indicadores de prontidão, revisão com snapshot e aplicação explícita da mudança de fase.

Para que serve

Separar análise, decisão e transição, preservando as evidências utilizadas.

Quando preencher ou revisar

Em revisões programadas, possível domínio, ausência de progresso ou necessidade de modificar, pausar ou encerrar.

Como preencher e utilizar

- Escolha o período relevante.
- Leia prontidão e limitações.
- Registre decisão e justificativa.
- Confirme validade social, assentimento, integridade e generalização.
- Aplique depois a transição pendente.
- Reserve alteração manual para correção administrativa.

Por que é relevante

Reduz mudanças acidentais e vincula a fase à revisão.

Atenção

Prontidão favorável não obriga mudança; cada revisão aplica apenas uma transição adjacente.

Perguntas rápidas

O critério foi atingido. A fase muda sozinha?

Não. O indicador apoia a análise, mas a transição exige decisão e justificativa.

Posso alterar uma definição, medida ou protocolo antigo?

Mudanças materiais devem gerar nova versão. Assim, cada sessão continua ligada ao que estava vigente.

Quando usar observação ABC?

Quando houver evento relevante em alvo de redução e for possível registrar antecedente, resposta e consequência de forma descritiva.

Um treinamento significa competência?

Não. O sistema separa os componentes da capacitação da competência efetivamente observada.

O administrador pode ver tudo?

A administração do ambiente não elimina limites de finalidade, autoria, privacidade e responsabilidade clínica.

Versão do manual: agosto de 2026